mantida conforme aparece nas imagens; trechos fotografados em sobreposição foram transcritos uma única vez.

[ORIGINAL: PÁGINA 1]

Questões

1. Considerando o laboratório na análise das causas mais frequentes de anemias no idoso, analise as afirmações abaixo e depois escolha a sequência de afirmações corretas (verdadeiras).

I- O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de discriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferro.

II- O exame com melhor relação custo/benefício e maior poder de discriminação entre a Anemia Ferropriva, e a Anemia da doença crônica, ambas frequentes, é a dosagem de Ferritina.

III- A Contagem de Reticulócitos é muito útil na diferenciação da Anemia Ferropriva da Anemia Megaloblástica, também importante causa de anemia no idoso.

IV- A pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser solicitada quando estivermos diante de uma anemia microcítica e hipocrômica, com anisocitose, no idoso.

A alternativa com as afirmações corretas (verdadeiras) é:

a. I e IV

b. II e IV

c. I, III e IV

d. II, III e IV

2. Correlacione as colunas, associando os métodos laboratoriais abaixo às questões correspondentes (Prova de Título de Especialista em Reumatologia 2005 68 Rev Bras Reumatol, v. 46, n. 1, p. 61-68, jan/fev, 2006, com adaptações)

a) Imunofluorescência direta

b) Imunofluorescência indireta

c) ELISA

d) Western blot

e) Imunodifusão radial

( ) Soro do paciente contém anticorpos contra antígenos do núcleo de células em esfregaço de lâmina. Reação é lida no microscópio de fluorescência, após a adição de anti-anticorpo marcado com fluoresceína.

( ) Soro do paciente é submetido a dosagem de C3 (ou pesquisa de anti-Ro, anti-La, anti Sd 70, por exemplo). O soro é colocado em placa de gel que contém anticorpos anti-C3 (ou anti-Ro, anti-La, anti Sd 70, por exemplo). Halo concêntrico se forma.

( ) Antígenos do DNA são separados do soro do paciente após corrente elétrica. A adição de anticorpos gera bandas específicas que podem ser radiografadas ou reveladas com corante.

( ) Espécime de biópsia de pele ou renal é submetido à pesquisa de IgG na junção dermo-epidérmica ou nos glomérulos e membrana. Uma anti-IgG marcada com fluoresceína é adicionada ao tecido.

( ) Soro do paciente é testado para anticorpos antiHbsAg. O soro é colocado em placas sólidas contendo HbsAg. Anti-anticorpos marcados com peroxidase são adicionados. A reação é lida em fotômetro após adição de cromogêneo.

A sequência correta é:

a. a-d-e-b-c

b. a-e-d-b-c

c. b-e-d-a-c

d. b-e-c-a-d

3. Correlacione adequadamente as colunas, cada anticorpo com a doença em que ele mais frequentemente está positivo:

1. Anti-histonas 2. c-ANCA 3. Anti-RNP 4. Anti-DNA nativo 5. Anti-SSA/Ro

[ORIGINAL: PÁGINA 2]

( ) Doença Mista do Tecido Conjuntivo

( ) Nefrite Lúpica

( ) LES induzido por drogas

( ) Granulomatose com Poliangeite - ex Granulomatose de Wegener

( ) Síndrome de Sjögren

A sequência correta está em:

a. 1,2,3,4,5

b. 1,5,4,2,3

c. 3,4,1,2,5

d. 5,1,2,4,3

4. Estreitamento difuso do espaço articular, erosões marginais, cistos subcondrais, osteopenia e edema de tecidos moles periarticulares são achados de imagem característicos de:

a. Osteoartrite;

b. Pioartrite;

c. Artropatia Inflamatória;

d. Gota.

5. São características do estudo radiográfico, EXCETO:

a. Método multiplanar;

b. Utiliza radiação ionizante;

c. Deve ser realizado preferencialmente em pelo menos duas incidências;

d. Acessível.

6. Quais os métodos de imagem mais utilizados atualmente no estudo das afecções osteoarticulares?

a. Radiografia, Bursografia, Cintilografia Óssea e Ressonância Magnética;

b. Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e Discografia;

c. Tomografia Computadorizada, Mielografia, Radiografia e Ressonância Magnética;

d. Radiografia, Ultrassonografia, Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética.

7. Uma paciente de 50 anos há 8 meses vem evoluindo com dor e edema nas articulações das mãos e pés. Refere intensa rigidez matinal de mais de 1 hora, mas nega fenômeno de Raynaud, lesões cutâneas ou aftas orais bem como outras comorbidades exceto pelo tabagismo pesado. Exame físico dos sistemas sem alterações. Exame articular apresenta dor e edema nas interfalangeanas proximais das mãos, metacarpofalangeanas bilaterais, punhos, joelhos e tornozelos. A radiografia das mãos mostra erosão óssea justa articular e o fator reumatoide em títulos altos. Em relação ao caso é correto afirmar:

a. A droga de escolha é a hidroxicloroquina

b. Deve ser iniciado o sulfato de glicosamina

c. Pode iniciar corticoide na dose antiinflamatória

d. A pregabalina deve ser iniciada após a crise

8. Sobre a gota, assinale a alternativa correta:

a. Classicamente se manifesta como monoartrite aguda, que se instala lentamente com poucos sinais flogísticos.

b. O nível sérico de ácido úrico pode ser normal durante a crise aguda de gota.

c. Se manifesta com crise recorrentes, porém não causa dano permanente nas articulações.

d. O alopurinol é a medicação indicada para tratar a crise aguda de gota.

9. Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico analise as seguintes assertivas.

I - A administração de imunossupressor, como a ciclofosfamida, está indicada no envolvimento sistêmico grave como a nefrite lúpica.

II - Pacientes com a presença de anticorpos antifosfolipedes devem receber anticoagulação

III - No lúpus observa-se um aumento das proteínas do complemento, indicando atividade de doença.

IV - A presença do anti DNA dupla hélice é um marcador de atividade de doença bem como um marcador de nefrite.

São corretas

[ORIGINAL: PÁGINA 3]

a. I e II

b. I, II e IV

c. II e III

d. I e IV

10. Qual doença abaixo não cursa com artrite erosiva?

a. Síndrome de Sjögren

b. Artrite reumatoide

c. Artrite gotosa

d. Artrite psoriásica.

11. De acordo com as recomendações 2019 do Colégio Americano de Reumatologia para o tratamento da osteoartrite de mãos, joelhos e quadril, são fortemente recomendadas as seguintes, EXCETO:

a. Órtese para a 1ª carpometacarpofalângica, nos casos de osteoartrite de mãos.

b. Uso de metotrexate via oral, nos casos de osteoartrite dos joelhos

c. Tai chi, nos casos de osteoartrite do quadril.

d. Uso de AINH tópico, nos casos de de osteoartrite dos joelhos.

12. Homem de 67 anos, profissão de advogado, refere dor no ombro direito, que irradia para o braço, de intensidade variável e que piora durante a noite, quando se deita deste lado. Refere que o quadro iniciou há seis meses. Há um mês, apresentando piora da dor e limitação ativa dos movimentos do ombro e crepitação aos movimentos. Considerando a possibilidade de síndrome do manguito rotador para este paciente, qual dos testes realizados para avaliação da integridade dos tendões do manguito é exclusivo para avaliação do supraespinal?

a. Yocum

b. Gerber

c. Patte

d. Jobe

13. RHFF, 41 anos, sexo feminino, advogada, procurou o ambulatório de Reumatologia, com dores difusas em todo o corpo, sono não reparador, ansiedade, com início dos sintomas há nove meses. Exame físico: sem sinais de artrite, dor a palpação muscular nos quatro membros, sem outras anormalidades. Exames complementares: VHS e PCR normais, fator reumatoide negativo e hemograma normal. Sobre o caso acima, é verdadeiro

a. Deve-se solicitar polissonografia, punção liquórica e eletroneuromiografia dos quatro membros.

b. A pregabalina é considerada segura e eficaz no alívio dos sintomas apresentados.

c. O diagnóstico mais provável é o lúpus eritematoso sistêmico.

d. Deve-se medicar com metotrexato e cloroquina.

14. O tratamento de primeira linha para osteoporose inclui como opção o uso de drogas anti-catabólicas, também conhecidas como anti-reabsortivas, destacando-se neste grupo os bisfosfonatos. Dentre os bisfosfonatos podemos citar:

a. Abaloparatida

b. Romosumabe

c. Denosumabe

d. Ibandronato

15. VAC, 44 anos, sexo masculino, professor, procurou o pronto socorro ortopédico para tratamento de entorse do joelho esquerdo, durante prática esportiva. Destacando-se que o paciente apresentava histórico de úlcera péptica e gastrite, no tratamento medicamentoso, deve-se utilizar preferencialmente:

a. Nimesulida

b. Piroxicam

c. Etoricoxibe.

d. Diclofenaco

16. A Osteoporose é uma desordem osteometabólica caracterizada por fragilidade óssea e predisposição a fraturas. Em pacientes com osteoporose sem fratura, a abordagem fisioterápica preventiva deve preferencialmente incluir:

[ORIGINAL: PÁGINA 4]

a. Hidroterapia

b. Alongamentos

c. Cinesioterapia global com impacto

d. Cinesioterapia localizada sem impacto

17. A Uma paciente de 88 anos foi admitida no serviço de urgência com fraqueza como queixa principal. Apresentava dispneia, sintomas gastrointestinais como náuseas e vômitos, dor abdominal, dispepsia, prurido e feridas na boca há 3 dias. Os sintomas foram progressivos. Na avaliação dos medicamentos consumidos foi determinado que ela está em uso contínuo de metotrexato (MTX) há cerca de 5 meses. Na busca da causa do uso de MTX e checagem das prescrições, foi revelado que a paciente recebeu por engano MTX ao invés de digoxina. Ela havia usado MTX 1,25 mg por 5 meses consecutivos, e 2,5 mg cinco dias por semana no último mês. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que indica a melhor opção terapêutica a ser instituída:

a. A retirada do MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)

b. A retirada do MTX e a administração de ácido fólico

c. A retirada do MTX e a administração de vitamina E

d. Continuação com MTX e a administração de ácido folínico (leucovorina)

5. Um paciente com insuficiência renal crônica em tratamento conservador, foi internado na Unidade Coronariana com angina instável. Apresentou, durante sua internação, quadro agudo de artrite na articulação metatarsofalangeana e tornozelo. Relatou que já havia sofrido quadro semelhante previamente. Considerando a sua hipótese diagnóstica, assinale a alternativa que melhor indica o diagnóstico de artrite e opção terapêutica a ser instituída.

a. Artrite Reumatoide e colchicina

b. Gota e alopurinol

c. Gota e antiinflamatório não hormonal

d. Gota e corticosteroides

19. Sobre a artrite reumatoide, julgue as alternativas e responda:

I. A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico a sinovial e causa o acúmulo de líquido nas articulações, perda debilitante de cartilagem, fraqueza óssea e deformidade articular. É uma condição crônica e progressiva, podendo haver longos períodos de remissão (sem sintomas).

II. Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com metotrexato.

III. Paciente com artrite reumatoide estabelecida e com baixa atividade da doença nunca fez uso de um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), deve iniciar a monoterapia com um inibidor do fator de necrose tumoral (TNF) como monoterapia.

IV. Paciente com artrite reumatoide estabelecida em caso de falha da monoterapia inicial com um medicamento antirreumático modificador da doença convencional (DMARD), por exemplo metotrexato, é indicada uma terapia com a combinação dupla ou tripla de DMARD convencional (Metotrexato, leflunomida, sulfassalazina, cloroquina e hidroxicloroquina).

20.

a. Apenas as alternativas I e II estão corretas.

b. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

c. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.

d. Todas as alternativas estão corretas.

20. A respeito dos fármacos antirreumáticos modificadores da doença, julgue as alternativas e responda:

[ORIGINAL: PÁGINA 5]

I. O metotrexato é um fármaco de primeira escolha, que tem atividade citotóxica e imunossupressora.

II. A tempo de ½ vida da leflunomida é reduzida pela interação medicamentosa com colestiramina A.

III. A ciclosporina inibe a atividade dos linfócitos T efetores CD8+.

IV. O tofacitinibe e o baricitibe são anticorpos monoclonais que inibem a via de sinalização JAK-STAT.

21.

a. Apenas as alternativas I e II estão corretas.

b. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas

c. Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.

d. Todas as alternativas estão corretas.

21. Qual das seguintes neoplasias é mais frequente na faixa etária pediátrica?

a. Tumor de células gigantes

b. Osteossarcoma

c. Condroblastoma

d. Condrossarcoma

22. Em relação aos tumores malignos de partes moles (sarcomas), assinale a alternativa INCORRETA:

a. As metástases são geralmente linfáticas

b. A ressonância magnética não é precisa na definição do tipo histológico

c. São mais frequentes em idosos

d. Localização em retroperitônio é associada a pior prognóstico

23. Paciente do sexo feminino, cor branca e 25 anos de idade. Procurou médico por apresentar aumento de volume na região do joelho direito e dor local intermitente. Ao exame físico apresentava limitação dos movimentos. A radiografia evidenciou lesão tibial epifisária, derrame articular, fratura patológica, rarefação óssea, fina trabeculação e limites nítidos. Na macroscopia da peça cirúrgica evidenciou-se lesão volumosa, densa, avermelhada e com lacunas hemorrágicas. Na microscopia a neoplasia é constituída por tecido com, rica vascularização e grande número de células gigantes multinucleadas. O diagnóstico menos provável é:

a. sarcoma fibromixoide de baixo grau

b. mieloma múltiplo

c. rabdomiossarcoma

d. sarcoma de Ewing

24. Criança é diagnosticada com displasia do desenvolvimento do quadril. Podemos dizer que o quadril instável é aquele que:

a. Está reduzido e luxa quando fazemos manobra de abdução

b. É aquele que tem a cabeça femural com 50% de cobertura pelo acetábulo

c. Está reduzido e luxa quando realizamos manobra de adução

d. Apresenta incongruência entre a epífise femural e o acetábulo

25. Você é cirurgião plástico e está explicando as vantagens do uso de uma auto-enxerto para seus residentes. Qual das seguintes afirmativas está correta?

Boa tolerância e incorporação

Evita um sítio doador

Sem limite de quantidade de tecido

Redução da morbidade inicial

26. Nas fraturas de úmero proximal a tuberosidade maior está desviada para:

a. Inferior e anterior

b. Inferior e posterior

[ORIGINAL: PÁGINA 6]

c. Superior e anterior

d. Superior e posterior

27. Paciente, 45 anos, sexo feminino apresenta fratura de úmero fechada com desvio, deve-se:

a. Colocar gelo no local e não imobilizar, uma vez que a fratura está desviada

b. Reduzir a fratura bem lentamente e imobilizar o local atingindo a articulação acima e abaixo da lesão

c. Colocar gelo sobre a área desviada e fazer curativo compressivo, antes de imobilizar apenas o local da fratura

d. Imobilizar o local, atingindo a articulação acima e abaixo da lesão, sem reduzir a fratura

28. Uma mulher de 75 anos, portadora de hemiplegia Direita pós AVCH foi reabilitada por um equipe multiprofissional por 1 ano, tendo evoluído de uma condição de dependência total em todas as atividades para uma condição de independência para autocuidados e dependência parcial para marcha e transferências. Após a alta deste Centro de Reabilitação, procurou outro serviço de reabilitação com objetivo de obter maior destreza para atividades bimanuais, pois decidiu dedicar aos trabalhos artesanais para obter seu sustento. Assinale a alternativa correta:

a. O programa de reabilitação não atingiu seu objetivo

b. Os autocuidados são o principal objetivo do programa de reabilitação

c. Como a paciente é hemiplégica, ela não vai conseguir destreza para atividades bimanuais, por isso necessita na verdade é de uma abordagem psicológica para trabalhar o limite de seus ganhos funcionais.

d. A mudança de objetivos do paciente durante o programa de reabilitação é frequente, conforme os ganhos funcionais, e a equipe deve estar atenta para isso.

29. Qual o 1 sinal clínico que deve chamar a atenção do médico para a possibilidade de lesão vascular em fraturas do ombro?

a. Parestesias

b. Pulso radial ausente

c. Palidez da mão

d. Diminuição da temperatura do membro

30. Sobre lombalgia marque a correta.

a. É uma queixa comum no consultório, com diagnóstico etiológico sendo esclarecido na maioria dos casos, sendo as compressões por hérnia e estenoses de cana lombar as maior causas

b. A maioria são lombalgias agudas.

c. Uma hérnia discal centro-lateral L4L5 provavelmente comprimirá a raiz de L5.

d. O tratamento inicial de um paciente com hérnia discal L4L5 com compressão nervosa importante à RM é o tratamento cirúrgico.

31. Paciente sexo feminino, 42 anos, sedentária, vem apresentando lombalgia há 3 meses. A dor piora a movimentação, não tem irradiação. Nega alterações esfincterianas, perda de peso, febre ou déficit de força. A conduta médica inicial deve ser:

a. Solicitar Ressonância de coluna lombar, por ter essa queixa de forma persistente e crônica.

b. Encaminhar a reabilitação para melhora da mobilidade, flexibilidade e fortalecimento muscular, e orientações posturais.

c. Prescrever anti-inflamatório associado a miorrelaxante por 6 semanas.

d. Provavelmente se trata de hérnia discal, pela característica da dor.

32. Os estágios de desenvolvimento das úlceras por pressão descritos por EDBERG são:

a. Hiperemia, isquemia, necrose e ulceração.

b. Necrose, isquemia, ulceração e hiperemia.

c. Isquemia, hiperemia, necrose e ulceração.

d. Ulceração, necrose, hiperemia e isquemia.

33. A escoliose idiopática do adolescente acomete principalmente?

a. Meninas entre 11 e 18 anos de idade

b. Meninos entre 11 e 18 anos de idade

c. Meninas entre 12 e 25 anos de idade

[ORIGINAL: PÁGINA 7]

d. Meninos entre 12 e 25 anos de idade

34. Um médico residente de geriatria estava acompanhando um paciente idoso e diagnosticou um tumor intestinal. O preceptor orientou que ele fizesse uso do protocolo SPIKES. O residente procurou seguir as orientações. Qual dos seguintes itens não é contemplado neste protocolo?

a. Ambiente adequado e postura profissional.

b. Acolhimento, escuta ativa e comunicação clara.

c. Percepção do desejo do paciente pela informação

d. Dar a informação de forma completa sobre o final da vida

AS QUESTÕES 35, 36, 37 e 38 REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO ABAIXO:

Senhor X, de 82 anos, hipertenso, diabético e portador de hipotireoidismo e neuropatia diabética. Fazia uso de Losartana, Anlodipino, Metformina, Pregabalina, Duloxetina e Levotiroxina. Pratica exercícios físicos regulares. Peso habitual: 60 Kg. Estatura: 1,64 m. IMC: 23 Kg/m². Circunferência de Panturrilha (CP): 33 cm. Nos últimos 6 meses, apesar do bom controle glicêmico e da função tiroidiana estar normal, diminuiu a ingestão de alimentos e perdeu 8 Kg. Há 30 dias, apresentou duas quedas da própria altura e, após as quedas, os níveis glicêmicos elevaram-se, sendo necessária a introdução de Insulina. Há uma semana, foi ao consultório do geriatra, sendo constatados: peso de 52 Kg, IMC de 20 Kg/m², CP de 30 cm, velocidade da marcha de 0,6 m/s e força de preensão palmar de 23 Kg. Levou o laudo de uma densitometria corporal total (DXA) mostrando massa muscular esquelética apendicular (braços e pernas) de 17 Kg.

35. Dentre as alterações apresentadas pelo Senhor X citadas abaixo, qual faz parte dos critérios do fenótipo de fragilidade de Fried (2001) para o diagnóstico de fragilidade?

a. Diminuição da CP para menos de 31 cm.

b. Queda da própria altura.

c. Redução da força de preensão palmar.

d. Diminuição do IMC para menos de 23 Kg/m2

36. De acordo com os dados clínicos apresentados pode-se dizer que, levando-se em conta o fato do Senhor X ser idoso, ele é portador de:

a. Comorbidade, polifarmácia e obesidade

b. Multimorbidade, polifarmácia e baixo peso

c. Complicações de doença crônica, mas não tem polifarmácia.

d. Multimorbidade complexa, polifarmácia e peso normal.

37. Os dados clínicos permitem afirmar que o Senhor X:

a. tem sarcopenia grave.

b. tem sarcopenia apenas

c. tem sarcopenia provável

d. não tem sarcopenia

38. Após otimização da prescrição medicamentosa, com retirada da Metformina e do Anlodipino e ajuste da dose da Insulina, Senhor X foi encaminhado a um fisioterapeuta para melhora da atividade física e iniciou um programa de intervenção nutricional. Apesar da hipertensão e da diabetes, a função renal estava preservada. Quanto de proteína ele deve ingerir por dia?

a. 52 g ao dia antes do café-da-manhã.

b. 78 g ao dia divididas nas três principais refeições

c. 156 g ao dia divididas nas três principais refeições.

d. 90 g ao dia em uma dose de suplemento após a atividade física.

39. A desprescrição de medicamentos está indicada para um paciente de mais de 80 anos principalmente quando ele faz uso regular de

a. medicamentos potencialmente inapropriados para idosos.

b. dois medicamentos para uma mesma doença crônica.

c. doses recomendadas para adultos jovens.

[ORIGINAL: PÁGINA 8]

AS QUESTÕES 40 E 41 REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO ABAIXO:

O Senhor Y de 63 anos, administrador, é trazido em consulta pela esposa que informa história de que há 2 anos o paciente começou a envolver-se em brigas e discussões, "não media mais as palavras", "não suportava ser corrigido". Nessa época foi demitido. Afirmava que era "mais brilhante que todos da empresa e isso despertou inveja". Tentou novo emprego, mas não conseguiu adaptar-se às novas tarefas. Logo, abandonou o emprego ("era um profissional muito bom para aquilo"). Há 6 meses está com perda de autocuidado e aumento exagerado do consumo de álcool. Frequentemente sai do banheiro e não fecha a calça, mesmo em locais públicos. Já expulsou visitas de casa sem motivo e de maneira grosseira. Mais recentemente, anda muito desinteressado, sem vontade e não se preocupa com ninguém, nem mesmo quando os seus dois netinhos pequenos adoecem. Durante a consulta a única queixa que apresenta é de dificuldade de dormir, mas levanta-se diversas vezes e caminha pelo consultório, vai até a janela e repete a mesma frase: "Vai chover logo". A pontuação do MEEM foi de 29 pontos, a do Pfeffer de 16 pontos e da Escala de Depressão Geriátrica foi de 1 ponto. Foi solicitada uma avaliação neuropsicológica que mostrou prejuízo na atenção, linguagem, planejamento, organização, resolução de problemas e abstração. Os outros domínios cognitivos estão preservados.

40. Assinale a alternativa que apresenta qual é o diagnóstico mais provável para o caso do Senhor Y.

a. Provável demência mista (Alzheimer associada à vascular)

b. Provável demência frontotemporal variante de linguagem.

c. Possível demência por doença de Alzheimer pré-senil.

d. Possível demência frontotemporal variante comportamental.

41. Você é o médico que está avaliando o Senhor Y. Fez a sua hipótese diagnóstica e solicitou exames laboratoriais e de imagem cerebral. Os exames laboratoriais não mostraram alterações que pudessem justificar o quadro e a Ressonância Magnética do Crânio não mostrou atrofia cerebral e o paciente tinha leve microangiopatia (Fazekas 1). Dentre os exames abaixo, qual você solicitaria a seguir por ser mais útil para a confirmação da hipótese diagnóstica?

a. Biomarcadores liquóricos (Proteínas TAU e Beta-amiloide)

b. SPECT (cintilografia de perfusão) cerebral

c. Eletroencefalograma.

d. Polissonografia.

42. A Síndrome da Imobilidade é muito conhecida pelos Geriatras e sua detecção impacta diretamente sobre o prognóstico e orientações aos familiares para cuidados com os pacientes. Sobre ela, assinale a alternativa que contenha um critério diagnóstico maior e um menor, respectivamente.

a. Déficit cognitivo grave e múltiplas contraturas.

b. Disfagia grave e dupla incontinência.

c. Múltiplas contraturas e afasia.

d. Lesão por pressão e disfagia.

43. A carga e a complexidade de sintomas ao fim de vida de diversas doenças crônicas são altas, assim, o ideal é que a avaliação dessas queixas sejam sistemáticas e regulares. Analise as afirmativas abaixo que se referem à escala de avaliação de sintomas de Edmonton (ESAS) e marque a alternativa verdadeira:

a. Trata-se de escala de graduação que classifica a intensidade do sintoma de forma qualitativa apenas (leve, moderado e intenso)

b. Avalia sempre vinte sintomas básicos, dentre os quais constam prurido, agitação psicomotora e alterações do aspecto da pele

c. Existe a possibilidade de acrescentar outros sintomas para serem avaliados além dos sintomas básicos sempre presentes na escala.

[ORIGINAL: PÁGINA 9 — OUTRA SEQUÊNCIA DE QUESTÕES, CONFORME FOTOGRAFIA]

[Continuação superior de questão anterior — (INCOMPLETO)]

(INCOMPLETO) ... entre os exames abaixo, qual seria o mais indicado?

(INCOMPLETO) ... clamídia, através, por exemplo, de imunofluorescência direta ou por Reação ...

(INCOMPLETO) ... corpúsculo de Donovan (em secreção corada pelo Gram da secreção drenada do bubão ...)

(INCOMPLETO) Bacterioscopia pelo Gram da secreção do bubão, com ênfase à pesquisa de diplococos Gram negativos, intra e extracelulares.

16) A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma das doenças mais prevalentes do idoso. Estima-se que cerca de 50% dos homens maiores de 80 anos apresentam essa condição. A respeito deste tema, assinale a alternativa incorreta.

a) O arsenal terapêutico medicamentoso envolve Alfa bloqueadores que relaxam a musculatura lisa da próstata e inibidores da enzima 5-alfa-redutase que bloqueiam a conversão de testosterona em di-hidrotestosterona.

b) Foram descritos efeitos apoptóticos induzidos por bloqueadores alfa-1 e finasterida. Porém, esses efeitos são descritos como secundários e não se tem certeza se eles efeitos são suficientes para o controle da HPB.

c) O tratamento farmacológico da HPB baseia-se na atuação dos fármacos sobre o componente mecânico desta patologia, com o uso de alfa-bloqueadores por diminuição do volume prostático e sobre o componente dinâmico com o uso de inibidores da 5-alfa-redutase.

d) Antagonistas para receptores alfa 1-A e alfa 1-D, como a alfuzonina, têm uma incidência de hipotensão postural menor, devido à sua maior seletividade sobre os subtipos de adrenorreceptores.

17) Acerca da farmacoterapia para tratamento da disfunção erétil, assinale a opção correta.

a) Aos pacientes com ausência de ereção no TEFI (Teste de ereção farmacoinuzida) independente da integridade do sistema de veno-oclusão, deve ser recomendado o tratamento intracavernoso intermitente (FIC).

b) Agentes vasodilatadores como a fentolamina e a papaverina constituem o tratamento de primeira linha principalmente para pacientes com disfunção erétil de origem mista.

c) O uso de drogas como etanol e de fármacos como determinadas classes de anti-hipertensivos e diuréticos estão associados com Disfunção Erétil de origem orgânica.

d) Agentes vasodilatadores como o alprostadil apesar de demonstrarem menor eficácia que os inibidores de PDE-5, são amplamente utilizados devido à conveniência de administração e baixa incidência de priapismo.

18) No conceito de injúria renal aguda é certo dizer:

a) Consiste no estágio 1 de IRA na KDIGO 2012.

b) Aumento da creatinina ≥ 0,3 mg/dl em 12h

c) Aumento da creatinina ≥ 2 vezes a basal, a qual é conhecida nos 7 dias anteriores.

d) Aumento da creatinina ≥ 2 vezes a basal, a qual é presumida.

19) Qual desses pacientes tem menor risco para injúria renal aguda?

a) Em uso de diurético

b) Idoso

c) Diabético

d) Alérgico a penicilina

20) A doença renal policística autossômica dominante tipo 1

a) Ocorre por mutação no gene PKD2

b) Ocorre por mutação no cromossomo 4

c) É a doença policística renal mais comum.

d) Acomete mais mulheres que homens.

21) Na hiponatremia dilucional:

I O sódio está baixo por perda de sódio na urina

II Um exemplo é a doença renal crônica

III O sódio está baixo por redistribuição da água para o terceiro espaço

IV O melhor tratamento é o uso de tiazídicos.

(ALTERNATIVAS INCOMPLETAS)

(INCOMPLETO) Paciente de 35 anos, masculino, ex-tabagista, é internado na UTI em insuficiência respiratória, devido à hemorragia [trecho à esquerda da fotografia cortado]. ... injúria renal aguda oligúrica e hipertensão arterial. Iniciado tratamento hemodialítico de urgência, anti-hipertensivos e investigação de causas secundárias para o quadro clínico. Laboratorialmente apresentava EAS com [trecho à esquerda cortado] ... hematúria e proteinúria com presença de cilindros hemáticos, proteinúria de 24 horas- 0,5 g/24 horas, ... sérica=5,5 mg/dL, ANCAs negativos e anticorpo anti-membrana basal reagente. O principal diagnóstico ... e etiológico neste caso são: (INCOMPLETO)

[ORIGINAL: PÁGINA 10 — GABARITO IDENTIFICADO COMO N2]

GABARITO COMENTADO

PROVÃO M1 • TURMA EF 68 | revisão técnico-bibliográfica independente | 20/10/2026

Escopo. O documento fonte possui 43 questões na sequência principal, com erros de numeração em alguns itens, e 6 questões adicionais de Urologia/Nefrologia (16–21), além de um fragmento de caso clínico sem alternativas completas. O antigo gabarito, localizado na última página, não foi utilizado e foi retirado. Nenhum texto de questão ausente foi criado.

Critério de marcação. “Com ressalva” designa a melhor resposta disponível, mas não uma afirmação universal. “Sem resposta única” e “anulável” indicam falha de formulação ou insuficiência de opções. Os comentários seguem os fatos presentes no documento e diretrizes consultadas, que podem diferir do contexto histórico da avaliação.

GABARITO RESUMIDO • SEQUÊNCIA PRINCIPAL

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	B (com ressalva)	16	C (individualizar)	31	B
2	C	17	A	32	A (ressalva histórica)
3	C	18	D	33	A
4	C	19	SEM RESPOSTA ÚNICA	34	D
5	A	20	B	35	C
6	D	21	B	36	B
7	C (apenas como medida adjuvante)	22	A	37	A
8	B	23	ANULÁVEL	38	B
9	D	24	C	39	A
10	A	25	A	40	D
11	B	26	D	41	B
12	D	27	D	42	C
13	B	28	D	43	C
14	D	29	B (não exclusivo)		
15	C (relativa)	30	C		

BLOCO ADICIONAL DE UROLOGIA/NEFROLOGIA: 16-C; 17-C; 18-C (ressalva); 19-D; 20-C; 21-somente II (sem opções). Fragmento pulmão-rim: sem letra atribuível.

COMENTÁRIOS • QUESTÕES 1–43

Questão 1 — B (com ressalva)

Ferritina é o marcador isolado mais útil do estoque de ferro; investigação de anemia ferropriva em idosos também deve buscar perda gastrointestinal.

A) Incorreta: ferro sérico oscila com inflamação e horário e não é o melhor teste isolado para diferenciar deficiências.

B) Mais adequada entre as opções: II é verdadeira. IV é aceitável como triagem histórica, mas pesquisa de sangue oculto não substitui endoscopia indicada.

C) Incorreta: I é falsa; a reticulocitometria mede resposta medular, não separa com confiança anemia ferropriva de megaloblástica isoladamente.

D) Incorreta: III não é critério discriminatório isolado e deve ser integrada ao VCM, esfregaço, B12 e folato.

Ressalva: A redação IV (“deve ser solicitada”) é excessiva: a avaliação etiológica não deve depender de sangue oculto nas fezes. Se tomada como obrigação universal, nenhuma opção é rigorosamente correta.

Fontes de apoio: [1]

Questão 2 — C

Sequência: imunofluorescência indireta (b) – imunodifusão radial (e) – Western blot (d) – imunofluorescência direta (a) – ELISA (c).

A) Incorreta: a primeira descrição usa anticorpos séricos sobre substrato, portanto não é fluorescência direta.

B) Incorreta: a primeira e a quarta descrições foram trocadas.

C) Correta: b-e-d-a-c corresponde, respectivamente, a leitura em lâmina, halo de precipitação, bandas eletroforéticas, pesquisa em tecido e reação enzimática.

D) Incorreta: o terceiro método é immunoblot/Western blot, não ELISA.

Ressalva: Há imprecisões nos exemplos de analitos na descrição da imunodifusão; o mecanismo físico descrito, contudo, identifica a técnica.

Fontes de apoio: [15]

Questão 3 — C

Anti-RNP → doença mista do tecido conjuntivo; anti-dsDNA → nefrite lúpica; anti-histona → lúpus induzido por fármacos; c-ANCA/PR3 → granulomatose com poliangeíte; anti-SSA/Ro → Sjögren.

A) Incorreta: associa anti-histonas com doença mista, trocando o par específico anti-RNP.

B) Incorreta: o segundo item não corresponde a c-ANCA, mas ao anti-dsDNA.

C) Correta: a sequência 3-4-1-2-5 reproduz as associações esperadas.

D) Incorreta: inicia com anti-SSA/Ro para doença mista, quando o marcador clássico é anti-RNP.

Fontes de apoio: [13], [18]

Questão 4 — C

Estreitamento relativamente uniforme, osteopenia periarticular, erosões marginais e edema de tecidos moles sugerem artropatia inflamatória, particularmente artrite reumatoide.

A) Incorreta: osteoartrite tipicamente produz osteófitos e esclerose subcondral, com estreitamento frequentemente assimétrico.

B) Incorreta como padrão principal: artrite séptica pode destruir rapidamente a articulação, mas exige contexto agudo e infectológico.

C) Correta: é o grupo que melhor reúne osteopenia justa-articular e erosões marginais.

D) Incorreta: gota crônica costuma produzir erosões “em saca-bocado” e preservação relativa do espaço articular no início.

Fontes de apoio: [2]

Questão 5 — A

Radiografia convencional é projeção bidimensional; tomografia e ressonância fornecem cortes multiplanares.

A) Correta como EXCETO: ser inerentemente multiplanar não caracteriza uma radiografia convencional.

B) Verdadeira: utiliza radiação ionizante; por isso não satisfaz o EXCETO.

C) Verdadeira: geralmente se obtêm ao menos duas projeções ortogonais.

D) Verdadeira: é exame amplamente disponível e de custo relativamente baixo.

Fontes de apoio: [16]

Questão 6 — D

Radiografia, ultrassom, TC e ressonância magnética são métodos usuais para avaliar estruturas osteoarticulares.

A) Incorreta: bursografia não integra rotineiramente os principais métodos de primeira linha.

B) Incorreta: discografia é invasiva e de indicação seletiva, não modalidade rotineira.

C) Incorreta: mielografia não é exame habitualmente usado como principal modalidade nesse cenário.

D) Correta: reúne os quatro métodos amplamente disponíveis na avaliação osteoarticular.

Fontes de apoio: [16]

Questão 7 — C (apenas como medida adjuvante)

O quadro sugere artrite reumatoide com erosões e soropositividade, que requer DMARD, usualmente metotrexato como fármaco de base. Corticoide pode ser ponte breve, não terapia modificadora definitiva.

A) Incorreta para este quadro erosivo e de pior prognóstico: hidroxicloroquina isolada não é a escolha preferencial.

B) Incorreta: glicosamina não trata a inflamação autoimune e não previne erosões de AR.

C) Correta apenas como possibilidade temporária para alívio dos sintomas, enquanto se institui DMARD.

D) Incorreta: pregabalina não trata sinovite nem reduz progressão estrutural.

Ressalva: A alternativa C é a única defensável, mas omite tratamento modificador da doença, essencial em paciente com erosões.

Fontes de apoio: [3], [4]

Questão 8 — B

Uricemia pode diminuir durante crise aguda e não exclui gota; diagnóstico definitivo quando possível pela identificação dos cristais no líquido sinovial.

A) Incorreta: início típico é rápido, com inflamação intensa.

B) Correta: urato sérico normal na crise não descarta gota.

C) Incorreta: artrite gotosa crônica pode causar tofos, erosões e dano permanente.

D) Incorreta: alopurinol reduz urato a longo prazo, mas não substitui anti-inflamatório no tratamento da crise.

Fontes de apoio: [5]

Questão 9 — D

I e IV são verdadeiras; anticorpos antifosfolípides isolados não determinam anticoagulação e atividade lúpica costuma consumir complemento.

A) Incorreta: II não é verdadeira para todo portador de anticorpos, sem trombose/SAF.

B) Incorreta: mantém II como se anticoagulação plena fosse sempre indicada.

C) Incorreta: III é falsa, pois C3 e C4 frequentemente diminuem nas exacerbações.

D) Correta: doença sistêmica grave pode requerer ciclofosfamida, e anti-dsDNA associa-se a atividade e nefrite.

Fontes de apoio: [6], [13], [18]

Questão 10 — A

A artrite associada à síndrome de Sjögren primária costuma ser não erosiva; as outras entidades podem produzir erosões.

A) Correta: é a menos associada ao padrão de artrite erosiva clássica.

B) Incorreta: AR frequentemente causa erosões marginais.

C) Incorreta: gota tofácea crônica pode ter erosões ósseas.

D) Incorreta: artropatia psoriásica pode provocar erosões e neoformação óssea.

Ressalva: Exceções existem, inclusive associação entre Sjögren e AR; o item pergunta pelo padrão habitual.

Fontes de apoio: [15]

Questão 11 — B

Na diretriz ACR/AF 2019, metotrexato é fortemente recomendado CONTRA na osteoartrite, ao contrário das outras medidas citadas.

A) Não é EXCETO: órteses de primeira carpometacarpiana têm forte recomendação.

B) Correta como EXCETO: não há benefício que sustente metotrexato oral para osteoartrite de joelho.

C) Não é EXCETO: tai chi tem forte recomendação no manejo de OA de quadril/joelho.

D) Não é EXCETO: AINE tópico tem forte recomendação na OA de joelho.

Fontes de apoio: [2]

Questão 12 — D

Jobe (empty can) avalia preferencialmente função/integridade do supraespinal; testes citados diferem quanto ao tendão e mecanismo.

A) Incorreta: Yocum investiga sobretudo impacto subacromial.

B) Incorreta: Gerber/lift-off testa subescapular.

C) Incorreta: Patte avalia principalmente infraespinal/rotação externa.

D) Correta: Jobe testa predominantemente supraespinal.

Ressalva: Nenhum teste clínico é absolutamente exclusivo ou confirmatório isoladamente; o termo “exclusivo” é impreciso.

Fontes de apoio: [16]

Questão 13 — B

Dor difusa, fadiga, sono não reparador e testes inflamatórios normais sugerem fibromialgia. Pregabalina pode beneficiar dor e sono em pacientes selecionados.

A) Incorreta: exames invasivos/eletrofisiologia sem indicação clínica não são rotina.

B) Mais adequada: pregabalina tem evidência de benefício modesto, com vigilância para tontura e sonolência.

C) Incorreta: ausência de inflamação/sinais sistêmicos torna LES menos provável.

D) Incorreta: metotrexato e antimalárico não são tratamento de fibromialgia.

Ressalva: Exercício graduado e educação são pilares com recomendação mais forte que fármacos.

Fontes de apoio: [7]

Questão 14 — D

Ibandronato é bisfosfonato; as demais substâncias pertencem a classes terapêuticas distintas.

A) Incorreta: abaloparatida é análogo de PTHrP com ação osteoanabólica.

B) Incorreta: romosozumabe é anticorpo contra esclerostina.

C) Incorreta: denosumabe é anticorpo anti-RANKL, antirreabsortivo, porém não bisfosfonato.

D) Correta: ibandronato inibe reabsorção óssea por osteoclastos e é um bisfosfonato.

Fontes de apoio: [15]

Questão 15 — C (relativa)

Quando AINE for imprescindível em pessoa com úlcera prévia, inibidores seletivos de COX-2 podem reduzir úlcera GI comparados aos não seletivos, sobretudo com proteção gástrica.

A) Incorreta como preferência: nimesulida não garante proteção gastrointestinal e tem risco hepático.

B) Incorreta: piroxicam tem risco gastrointestinal elevado e meia-vida prolongada.

C) Mais adequada dentre opções: etoricoxibe é seletivo COX-2; exige avaliação de risco cardiovascular e gastroproteção quando indicada.

D) Incorreta: diclofenaco mantém risco GI e cardiovascular, sem vantagem clara no antecedente de úlcera.

Ressalva: Em geral, priorizar tratamento não farmacológico, paracetamol ou AINE tópico, conforme quadro; COX-2 não torna a prescrição automaticamente segura.

Fontes de apoio: [8]

Questão 16 — C (individualizar)

Exercício resistido e exercícios com descarga mecânica/impacto seguro podem aumentar força e estimular osso em osteoporose sem fratura, conforme risco de queda.

A) Menos completo: hidroterapia ajuda mobilidade, mas baixa carga gravitacional reduz estímulo osteogênico.

B) Menos completo: alongamento isolado não produz estímulo suficiente para fortalecimento/saúde óssea.

C) Mais adequado: treino global com carga e impacto progressivo é eficaz quando tolerado e seguro.

D) Menos adequado como regra: cinesioterapia localizada sem carga fica aquém de treinamento funcional/resistido individualizado.

Ressalva: Em osteoporose grave/alto risco vertebral, impacto elevado e flexões forçadas podem ser inadequados; a prescrição deve ser individualizada.

Fontes de apoio: [16]

Questão 17 — A

Uso inadvertido crônico de metotrexato com mucosite e sintomas sistêmicos sugere toxicidade. Suspender imediatamente e administrar ácido folínico (leucovorina) sob avaliação hospitalar.

A) Correta: leucovorina contorna inibição do metabolismo do folato; verificar hemograma, função renal e necessidade de medidas adicionais.

B) Incorreta: ácido fólico é usado em prevenção/rotina, não substitui resgate com leucovorina em intoxicação.

C) Incorreta: vitamina E não reverte toxicidade do metotrexato.

D) Incorreta: manter o agente responsável perpetua intoxicação.

Fontes de apoio: [15]

Questão 18 — D

Monoartrite aguda de primeira metatarsofalangeana em portador de DRC é compatível com gota. Corticosteroide é opção para a crise quando AINE é desfavorável.

A) Incorreta: artrite reumatoide é improvável pela apresentação, e colchicina exige adequação na DRC.

B) Incorreta para o tratamento IMEDIATO da crise: alopurinol é urato-redutor, não anti-inflamatório; pode ser iniciado durante crise com profilaxia em casos indicados.

C) Incorreta como melhor opção: AINE pode agravar função renal e cardiopatia.

D) Correta: corticoides orais ou intra-articulares podem tratar crise, após excluir artrite séptica.

Fontes de apoio: [5]

Questão 19 — SEM RESPOSTA ÚNICA

A assertiva I é correta; III é incorreta. A assertiva II prescreve metotrexato universalmente em baixa atividade, contrariamente à preferência condicional por hidroxicloroquina no ACR 2021. A IV descreve uma estratégia possível, mas não obrigatória após falha.

A) Problema: I é verdadeira, II não pode ser considerada uma obrigação geral para baixa atividade.

B) Incorreta: acrescenta III, que recomenda TNF-bloqueador como monoterapia inicial sem justificativa.

C) Resposta histórica possivelmente esperada: I, II e IV. Hoje, II e a indicação categórica de IV exigem ressalvas importantes.

D) Incorreta: III é falsa e nem todas as assertivas podem ser aceitas.

Ressalva: Não se deve apresentar C como única correta conforme diretrizes atuais; a estratégia após falha varia conforme fatores de prognóstico, atividade e segurança.

Fontes de apoio: [3], [4]

Questão 20 — B

I: MTX é DMARD de referência. II: colestiramina acelera eliminação da teriflunomida, metabólito ativo da leflunomida. III: ciclosporina inibe ativação de linfócitos T. IV é falsa: tofacitinibe/baricitinibe são pequenas moléculas, não anticorpos monoclonais.

A) Incorreta/incompleta: omite a ação da ciclosporina sobre linfócitos T.

B) Correta: I, II e III são compatíveis com a farmacologia; IV é falsa.

C) Incorreta: inclui IV, que classifica erradamente inibidores de JAK como anticorpos.

D) Incorreta: incorpora IV falsa.

Ressalva: A assertiva III é simplificadora: ciclosporina inibe calcineurina e ativação de linfócitos T, não apenas CD8+.

Fontes de apoio: [3]

Questão 21 — B

Osteossarcoma é o tumor ósseo maligno primário clássico de adolescentes e adultos jovens, particularmente na segunda década.

A) Incorreta: tumor de células gigantes predomina após maturidade esquelética.

B) Correta: osteossarcoma é mais frequente no grupo pediátrico que os demais diagnósticos listados.

C) Incorreta: condroblastoma também ocorre em jovens, mas é tumor raro e geralmente benigno.

D) Incorreta: condrossarcoma predomina na idade adulta.

Fontes de apoio: [16]

Questão 22 — A

Sarcomas de partes moles geralmente disseminam por via hematogênica, sobretudo para pulmões; via linfática é menos comum.

A) Correta como INCORRETA: metástases são predominantemente hematogênicas, não linfáticas.

B) Verdadeira: RM caracteriza extensão local, mas a histologia requer biópsia.

C) Verdadeira: incidência de sarcomas de partes moles, no agregado, é maior em adultos/idosos.

D) Verdadeira: localização retroperitoneal associa-se a dificuldade de ressecção e pior prognóstico.

Fontes de apoio: [16]

Questão 23 — ANULÁVEL

Mulher jovem com lesão epifisária tibial e numerosas células gigantes sugere tumor de células gigantes do osso, que NEM sequer aparece entre as alternativas. Todas as opções trazem diagnósticos discordantes em maior ou menor grau.

A) Não é diagnóstico típico: sarcoma fibromixoide de baixo grau tem histologia e perfil distintos.

B) Não é diagnóstico típico: mieloma múltiplo é incomum aos 25 anos e mostra proliferação plasmocitária.

C) Não é diagnóstico típico: rabdomiossarcoma é neoplasia muscular, não corresponde à descrição epifisária.

D) Não é diagnóstico típico: sarcoma de Ewing costuma ser diafisário/metadiafisário e de pequenas células redondas.

Ressalva: Não há critério objetivo para determinar o “menos provável” entre quatro hipóteses que não descrevem a neoplasia real; evitar atribuir letra.

Fontes de apoio: [16]

Questão 24 — C

Quadril instável, no teste de Barlow, encontra-se reduzido, porém pode ser luxado com adução e pressão posterior controlada.

A) Incorreta: abdução é empregada sobretudo na redução/Ortolani, não na provocação típica de luxação.

B) Incorreta: cobertura acetabular isolada não define instabilidade dinâmica.

C) Correta: adução e força posterior desencadeiam luxação de quadril instável.

D) Incorreta como definição específica: incongruência descreve quadril já deslocado/displásico, não o teste de instabilidade.

Fontes de apoio: [16]

Questão 25 — A

Aut enxerto utiliza tecido da própria pessoa, habitualmente com melhor compatibilidade e integração, sem rejeição alogênica.

A) Correta: boa tolerância e incorporação são vantagens dos autoenxertos.

B) Incorreta: é necessário um sítio doador e existe morbidade de retirada.

C) Incorreta: volume de tecido disponível é limitado por segurança e anatomia.

D) Incorreta como vantagem geral: pode aumentar morbidade inicial devido ao sítio doador.

Ressalva: O documento não nomeia letras nas quatro afirmações; a avaliação assume a ordem de apresentação como A a D.

Fontes de apoio: [16]

Questão 26 — D

A tração do supraespinal e infraespinal na fratura da tuberosidade maior favorece deslocamento superior e posterior.

A) Incorreta: o vetor muscular não é predominantemente inferoanterior.

B) Incorreta: não se espera deslocamento inferior.

C) Incorreta: posterior é possível, mas a componente usual é superior, e não anterior.

D) Correta: direção superoposterior é a tendência anatômica clássica.

Fontes de apoio: [16]

Questão 27 — D

Em primeira abordagem de fratura desviada, imobilizar e documentar perfusão/sensibilidade; reduções exigem equipe capacitada e indicações específicas.

A) Incorreta: manter fratura sem imobilização amplia dano e dor.

B) Incorreta como regra de socorro: não reduzir arbitrariamente uma fratura fechada sem avaliação adequada.

C) Incorreta: compressão e imobilização que não abrangem articulações adjacentes são insuficientes.

D) Correta: imobilização incluindo articulações proximal e distal, com avaliação neurovascular.

Ressalva: Urgência vascular/comprometimento cutâneo pode justificar redução imediata por profissional habilitado.

Fontes de apoio: [16]

Questão 28 — D

Reabilitação é orientada por metas pactuadas com o paciente e pode evoluir de autocuidado a atividades produtivas conforme ganhos funcionais.

A) Incorreta: obtenção de independência de autocuidados representa avanço importante.

B) Incorreta: autonomia para autocuidados é relevante, mas não o único objetivo de reabilitação.

C) Incorreta: hemiplegia não determina incapacidade absoluta de adaptação bimanuais.

D) Correta: metas e necessidades ocupacionais mudam ao longo da reabilitação.

Fontes de apoio: [16]

Questão 29 — B (não exclusivo)

Ausência de pulso radial é sinal de alerta para lesão vascular após fratura de ombro/proximal do úmero e exige avaliação imediata.

A) Sinal possível: parestesia pode indicar lesão nervosa ou isquemia, mas é inespecífica.

B) Mais objetivo: ausência de pulso distal impõe suspeita de lesão arterial.

C) Sinal possível: palidez também sugere isquemia; não é necessariamente posterior à perda de pulso.

D) Sinal possível: extremidade fria indica perfusão comprometida.

Ressalva: Vários sinais são clinicamente importantes; “primeiro sinal” não possui ordem temporal fixa.

Fontes de apoio: [16]

Questão 30 — C

Hérnia discal posterolateral em L4-L5 costuma afetar a raiz transitante L5.

A) Incorreta: lombalgia é predominantemente inespecífica, sem diagnóstico estrutural definido na maioria.

B) Incorreta como afirmação categórica: episódios agudos são comuns, mas não define etiologia e duração da maioria dos atendimentos.

C) Correta: raiz L5 é afetada na herniação paracentral L4-L5.

D) Incorreta: indicação cirúrgica depende de déficit progressivo, síndrome da cauda equina ou refratariedade, não apenas RM.

Fontes de apoio: [17]

Questão 31 — B

Lombalgia mecânica sem sintomas radiculares nem sinais de alarme favorece atividade, exercício/reabilitação e educação.

A) Incorreta como rotina: RM não é primeira conduta em ausência de bandeiras vermelhas e quando não alteraria manejo.

B) Correta: reabilitação, fortalecimento progressivo e orientações funcionais.

C) Incorreta: AINE com relaxante por seis semanas impõe exposição prolongada desnecessária.

D) Incorreta: hérnia de disco sintomática costuma incluir dor radicular, ausente aqui.

Fontes de apoio: [17]

Questão 32 — A (ressalva histórica)

No esquema histórico referido na questão, descreve-se hiperemia → isquemia → necrose → ulceração; porém tal sequência não substitui a classificação contemporânea por estágios de lesão por pressão.

A) Provável resposta pretendida: acompanha a sequência histórica apresentada (hiperemia, isquemia, necrose e ulceração).

B) Incorreta: coloca necrose antes da fase isquêmica.

C) Incorreta para o esquema histórico de estágios cutâneos: inicia com isquemia anterior à hiperemia observável.

D) Incorreta: inicia pela ulceração, que é etapa tardia.

Ressalva: Não foi localizada nesta pesquisa uma fonte primária robusta para a atribuição a “Edberg”; biologicamente a pressão compromete perfusão antes da hiperemia visível. Interpretar como nomenclatura didática antiga, não recomendação atual.

Fontes de apoio: [8]

Questão 33 — A

Escoliose idiopática do adolescente é mais comum em meninas, principalmente no período de crescimento puberal.

A) Correta: faixa etária e sexo de maior prevalência/progressão.

B) Incorreta: meninos também podem apresentar, mas menos frequentemente.

C) Incorreta: intervalo até 25 anos ultrapassa a classificação habitual de adolescência.

D) Incorreta: combina sexo menos prevalente e idade não apropriada.

Fontes de apoio: [16]

Questão 34 — D

O SPIKES estrutura preparação, percepção, convite quanto à informação, comunicação dos fatos, resposta às emoções e planejamento; não exige revelar “todo o final da vida”.

A) Incluída: ambiente e postura integram Setting.

B) Incluída: acolhimento e comunicação empática são centrais ao protocolo.

C) Incluída: Invitation verifica o quanto a pessoa deseja saber.

D) Correta como NÃO contemplada: fornecer indiscriminadamente informação completa sobre fim da vida viola adequação, contexto e preferência.

Fontes de apoio: [12]

Questão 35 — C

Fenótipo de fragilidade de Fried envolve perda involuntária de peso, exaustão, baixa atividade, velocidade lenta e fraqueza da preensão.

A) Incorreta: circunferência da panturrilha é usada em avaliação nutricional/muscular, não é item clássico de Fried.

B) Incorreta: quedas são consequência/associação, não critério direto do fenótipo.

C) Correta: baixa força de preensão manual é um dos cinco critérios.

D) Incorreta: IMC abaixo de 23 não integra os cinco critérios.

Fontes de apoio: [9]

Questão 36 — B

Há múltiplas doenças crônicas, seis fármacos contínuos e IMC atual 20 kg/m², com perda ponderal marcante (13%).

A) Incorreta: não há obesidade; IMC atual é baixo para muitos critérios geriátricos.

B) Mais adequada: multimorbidade, polifarmácia e baixo peso/risco nutricional.

C) Incorreta: seis medicamentos usuais caracterizam polifarmácia, independentemente do número de comprimidos.

D) Incorreta: há múltiplas condições, mas o perfil ponderal não é normal para interpretação geriátrica usual.

Fontes de apoio: [8], [9]

Questão 37 — A

Força de preensão de 23 kg em homem, massa apendicular 17 kg/1,64² = 6,32 kg/m² e marcha de 0,6 m/s configuram força, massa e desempenho reduzidos no EWGSOP2.

A) Correta: baixa força, baixa quantidade muscular e baixo desempenho confirmam sarcopenia grave.

B) Incorreta: omite a gravidade funcional demonstrada pela marcha lenta.

C) Incorreta: há medida de massa muscular, logo não se restringe a sarcopenia provável.

D) Incorreta: preensão de 23 kg está abaixo do ponto de corte masculino de 27 kg.

Fontes de apoio: [9]

Questão 38 — B

Com 52 kg e risco nutricional, 1,2–1,5 g/kg/dia é faixa frequentemente indicada, o que corresponde a até 78 g/dia; dividir nas refeições favorece aporte.

A) Incorreta: 52 g/dia é 1,0 g/kg e “antes do café” não faz sentido como ingestão única.

B) Correta: 78 g/dia = 1,5 g/kg/dia, distribuídos entre refeições.

C) Incorreta: 156 g/dia = 3 g/kg/dia, acima da necessidade usual.

D) Incorreta: 90 g em dose única não segue distribuição proteica e é desproporcional.

Ressalva: Avaliar estado clínico e tolerância renal; função renal preservada foi informada no enunciado.

Fontes de apoio: [10], [14]

Questão 39 — A

Presença de medicamentos potencialmente inapropriados justifica revisão estruturada e, quando houver relação desfavorável benefício/risco, desprescrição planejada.

A) Correta: indicação especialmente importante para rever riscos, interações e metas terapêuticas.

B) Incorreta: dois fármacos para a mesma doença podem ser terapia combinada apropriada.

C) Incorreta como regra: doses típicas de adultos jovens exigem individualização, mas não determinam automaticamente desprescrição.

Ressalva: Alternativa D não existe no arquivo; comentários limitados às três opções efetivamente presentes.

Fontes de apoio: [8]

Questão 40 — D

Desinibição, perda de empatia, compulsões, hipersexualidade/comportamento social inadequado e disfunção executiva com memória relativamente preservada sugerem demência frontotemporal variante comportamental.

A) Incorreta: Alzheimer + componente vascular não explica melhor a síndrome predominantemente comportamental.

B) Incorreta: não predomina afasia primária progressiva.

C) Incorreta: déficits amnésicos progressivos predominantes não foram relatados.

D) Mais adequada: critérios clínicos permitem hipótese de DFT variante comportamental; confirmação exige investigação adicional.

Ressalva: Classificações “possível” e “provável” dependem de critérios clínicos e imagem; a RM sem atrofia não afasta a hipótese.

Fontes de apoio: [11]

Questão 41 — B

Diante de forte suspeita de DFT com RM sem atrofia relevante, exame funcional cerebral por SPECT de perfusão ou FDG-PET pode auxiliar a demonstrar acometimento frontotemporal.

A) Incorreta como primeira complementação específica: tau e amiloide são mais ligados à investigação da patologia Alzheimer.

B) Correta: SPECT de perfusão está entre exames sugeridos quando permanece dúvida sobre DFT.

C) Incorreta: EEG não é confirmatório para esse padrão de demência.

D) Incorreta: polissonografia avalia distúrbios de sono, não diagnóstico de DFT.

Fontes de apoio: [11]

Questão 42 — C

Nos critérios clínicos tradicionais da síndrome da imobilidade, múltiplas contraturas são critério maior, enquanto afasia é critério menor.

A) Incorreta: associa dois critérios usualmente classificados como maiores.

B) Incorreta: disfagia e dupla incontinência integram critérios menores.

C) Correta: múltiplas contraturas (maior) + afasia (menor).

D) Incorreta: lesão por pressão e disfagia representam critérios menores.

Ressalva: Esses são critérios didáticos usados em geriatria brasileira; sua aplicação demanda avaliação clínica ampla.

Fontes de apoio: [8]

Questão 43 — C

ESAS (Edmonton) usa escalas numéricas 0–10 para sintomas básicos e aceita acréscimo de outros sintomas conforme necessidades.

A) Incorreta: a escala principal é numérica, não apenas qualitativa.

B) Incorreta: número básico não é fixado em 20 sintomas, e os exemplos dados não são todos obrigatórios.

C) Correta: outros sintomas podem ser adicionados além do conjunto principal.

Ressalva: A alternativa D não consta no PDF; não foi criada nem comentada.

Fontes de apoio: [15]

COMENTÁRIOS • QUESTÕES ADICIONAIS M2

Este bloco existe ao final das páginas de questões e repete números usados na sequência principal. As respostas são apresentadas separadamente para evitar confusão.

M2 – questão 16 — C

O componente dinâmico da HPB é reduzido por alfa-bloqueadores; o componente de volume é reduzido por inibidores da 5-alfa-redutase.

A) Verdadeira: descreve as duas classes e seus alvos principais.

B) Parcialmente verdadeira: alterações apoptóticas foram investigadas, mas não são o principal mecanismo de benefício dos alfa-bloqueadores.

C) Correta como INCORRETA: inverte os mecanismos ao atribuir redução volumétrica aos alfa-bloqueadores e relaxamento dinâmico aos 5-ARI.

D) Imprecisa: alfuzosina tem uro-seletividade funcional, não seletividade robusta por subtipos α1A/α1D que explique, por si só, todo o perfil de hipotensão.

Ressalva: Pela imprecisão da D, item pode ser questionado, mas C tem erro inequívoco.

Fontes de apoio: [15]

M2 – questão 17 — C

Álcool e alguns anti-hipertensivos/diuréticos podem estar associados a disfunção erétil, conforme dose e condições clínicas.

A) Incorreta: falha em teste fármaco-induzido não significa automaticamente que injeção intracavernosa intermitente seja a indicação correta.

B) Incorreta: papaverina/fentolamina não são primeira linha rotineira; inibidores PDE-5 são usualmente usados inicialmente.

C) Correta: álcool e determinados fármacos podem contribuir para disfunção erétil orgânica ou mista.

D) Incorreta: alprostadil intracavernoso é invasivo e pode causar dor/priapismo; não é preferido pela conveniência.

Fontes de apoio: [15]

M2 – questão 18 — C (com ressalva)

KDIGO caracteriza LRA por aumento de creatinina ≥0,3 mg/dL em 48 h, aumento ≥1,5 vez em até 7 dias ou oligúria persistente.

A) Incorreta: LRA abrange estágios 1–3; não equivale ao primeiro estágio.

B) Incorreta: 0,3 mg/dL é critério em 48 h, não em 12 h; se em 12 h, ainda satisfaz aumento observado no intervalo de 48 h, o que torna a literalidade ambígua.

C) Mais adequada: duplicação da creatinina em 7 dias confirma LRA se a temporalidade for demonstrada.

D) Imprecisa: “presumida” isoladamente carece de definição do intervalo temporal e referência basal.

Ressalva: Alternativa B também pode ser biologicamente verdadeira caso elevação tenha ocorrido em 12 horas; a prova confunde limite máximo de observação com tempo mínimo, razão de possível recurso.

Fontes de apoio: [15]

M2 – questão 19 — D

Idade avançada, diabetes e uso de diuréticos podem aumentar vulnerabilidade à LRA; alergia a penicilina, isoladamente, não é fator clássico de risco.

A) Não é menor risco: volume intravascular pode ser reduzido por diuréticos.

B) Não é menor risco: reserva renal menor e comorbidades aumentam susceptibilidade.

C) Não é menor risco: diabetes aumenta risco em diversos contextos.

D) Correta: alergia isolada não eleva o risco basal de LRA.

Fontes de apoio: [15]

M2 – questão 20 — C

DRPAD tipo 1 decorre geralmente de mutações PKD1 no cromossomo 16 e é mais frequente que o tipo 2 (PKD2, cromossomo 4).

A) Incorreta: PKD2 define o tipo 2.

B) Incorreta: PKD1 localiza-se no cromossomo 16.

C) Correta: tipo 1 é a forma mais comum da doença policística autossômica dominante.

D) Incorreta: não há predominância feminina marcante definidora.

Fontes de apoio: [15]

M2 – questão 21 — SOMENTE II (SEM OPÇÕES)

Hiponatremia dilucional resulta de água em excesso em relação ao sódio; DRC avançada com retenção hídrica é causa possível.

A) I - Falsa: perda real de sódio não define hiponatremia dilucional.

B) II - Verdadeira: retenção de água na doença renal pode diluir sódio plasmático.

C) III - Falsa: terceiro espaço corresponde a redistribuição de fluidos, não ao mecanismo geral de diluição plasmática.

D) IV - Falsa: tiazídicos podem causar ou agravar hiponatremia, não são terapia usual.

Ressalva: As opções de sequência não aparecem no documento original.

Fontes de apoio: [15]

Fragmento adicional sem número

O trecho final descreve hemorragia pulmonar, insuficiência renal aguda, cilindros hemáticos e anticorpo anti-MBG positivo. A hipótese é doença anti-membrana basal glomerular (síndrome pulmão-rim/Goodpasture). O documento não contém enunciado nem alternativas completos: esta resposta é explicação provável, não gabarito de letra.

REFERÊNCIAS VERIFICÁVEIS

Numeração entre colchetes ao final de cada comentário. Priorizar critérios e protocolos atuais quando conflitarem com formulações antigas da prova.

[1] AGA 2020, investigação gastrointestinal da anemia ferropriva
https://gastro.org/clinical-guidance/gastrointestinal-evaluation-of-iron-deficiency-anemia/

[2] ACR 2019, diretriz de osteoartrite de mãos, quadril e joelho
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10518852/

[3] ACR 2021, tratamento de artrite reumatoide
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9273041/

[4] EULAR 2025, atualização terapêutica da artrite reumatoide
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41826212/

[5] ACR 2020, manejo da gota
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.41247

[6] EULAR 2019, síndrome antifosfolípide
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11034817/

[7] EULAR 2016/2017, manejo de fibromialgia
https://ard.bmj.com/content/76/2/318.long

[8] AGS Beers 2023, medicamentos potencialmente inapropriados
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12478568/

[9] EWGSOP2 2019, sarcopenia: definição, critérios e pontos de corte
https://doi.org/10.1093/AGEING/AFY169

[10] ESPEN, proteína e exercício para idosos
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4208946/

[11] NICE NG97, avaliação dos subtipos de demência
https://www.nice.org.uk/guidance/ng97/chapter/Recommendations

[12] Baile et al. / SPIKES, aplicação do protocolo no Brasil
https://www.scielo.br/j/rbem/a/5qBdL9YrscGF8chzfcrqrXP/?lang=pt

[13] ACR 2024, diretriz de nefrite lúpica e marcadores
https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.25528

[14] PROT-AGE, recomendações de ingestão proteica no idoso
https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.05.021

[15] American College of Rheumatology, diretrizes em reumatologia (índice)
https://rheumatology.org/clinical-practice-guidelines

[16] AO Surgery Reference, tratamento e princípios de fraturas
https://surgeryreference.aofoundation.org/

[17] NICE, low back pain and sciatica in over 16s (NG59)
https://www.nice.org.uk/guidance/ng59/chapter/recommendations

[18] EULAR 2019, manejo do lúpus
https://ard.bmj.com/content/78/6/736